Dotation pour soins urgents et chariot d'urgence

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Ce que dit le droit, qui établit la liste, comment stocker, contrôler et tracer.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME · IEM sans PUI — médecin coordonnateur / d'établissement, pharmacien, IDEC

À RETENIR

Sans PUI, l'établissement peut détenir une dotation pour soins prescrits en urgence : liste établie par le pharmacien conventionné et un médecin désigné par la direction, rangement dédié fermé. Pas de liste nationale.

Sources : CSP R5126-108 et R5126-109 (décret n° 2019-489) · CSP L5126-10

CADRE JURIDIQUE

- **R5126-108** : médicaments et DM stériles « pour répondre à des besoins de soins prescrits en urgence », sur une **liste** établie par le **pharmacien conventionné** et **un médecin** de l'établissement **désigné par la direction**.
- **R5126-109** : rangement **dédié, fermé à clé** ou sécurité équivalente.
- EHPAD : convention officine et **pharmacien référent** (L5126-10 II) ; R5126-108 vise le I : application admise par les OMéDIT, non littérale.

Sources : CSP R5126-108, R5126-109, L5126-10 · OMéDIT CVL (02/2025) · OMéDIT IDF/ARS IDF (09/2025)

MATÉRIEL D'URGENCE IMPOSÉ SELON LA STRUCTURE

- **MAS, FAM, EAM** : matériel de **restitution et maintien des fonctions vitales** + convention de transfert.
- **IEM** : **oxygénothérapie et aspiration** ; personnel soignant formé sous la responsabilité d'un médecin.
- **Polyhandicap** : **oxygénothérapie**, même exigence de formation.
- **IME**, **EHPAD** : pas de chariot imposé par un texte national trouvé ; recommandations OMéDIT.
- **DSA** : utilisable par **toute personne**.

Sources : CASF D344-5-6, D312-74, D312-94 · CSP R6311-15

TROIS DOTATIONS DISTINCTES

Urgence vitale : trousse, sac ou chariot

- Liste **restreinte**, **scellé numéroté**, auprès du patient **en 3 min** ; jamais dans un local fermé à clé. Contenu : **outil « chariot d'urgence DOTR »**.

Urgence relative : stock tampon

- Sur **prescription** (télé-prescription comprise) ou protocole signé ; armoire **fermée à clé** ; accès prévu pour l'IDE d'astreinte et le médecin extérieur.

« Personnel de nuit » (sans IDE)

- Option EHPUR : quelques spécialités en **unités préparées par l'IDE**, pour une prescription du 15 ; sans accès au reste du stock. **Non injectable seulement** (choix DOTR).

Sources : OMéDIT IDF/ARS IDF, urgences en EHPAD : dotations (VDEF 24/09/2025) · RESUVal/ARS ARA, urgences en EHPAD (03/2021) · arrêté du 26/06/2026, art. 2

QUI FAIT QUOI

- **Médecin désigné + pharmacien** : établissent la liste, la révisent selon le public et les utilisations.
- Validation avec l'**IDEC** et le **référent médicaments** ; réassort de la trousse vitale sur prescription du médecin coordonnateur.
- **Planning de vérification** : IDEC, cadre ou référent médicaments ; tous les soignants y participent.
- Régulateur informé des **compétences présentes** : un AS ne se sert pas dans le stock global.

Sources : CSP R5126-108 · OMéDIT IDF/ARS IDF (09/2025) · OMéDIT CVL (02/2025)

CONTRÔLE, PÉREMPTION, TRAÇABILITÉ

- ☐ Trousse vitale : après **chaque utilisation** et **chaque mois** ; émargement daté, signé ; n° de scellé ouverture / fermeture
- ☐ Remplacer ce qui périme dans **≤ 2 mois**
- ☐ Stock tampon : contrôle ≤ tous les 4 mois ; **péremptions chaque mois**
- ☐ DSA (batterie, électrodes), aspiration testée, autonomie de l'O2
- ☐ Thermosensibles à part ; stupéfiants au coffre, identifiés
- ☐ Chaque utilisation tracée ; aucune réintégration du traitement d'un résident
- ☐ Périmé ou manquant : **FEI**

Sources : OMéDIT IDF/ARS IDF, dotations en EHPAD (VDEF 24/09/2025) · OMéDIT CVL (02/2025)

POINTS DE VIGILANCE

- **Prédosés nominatifs** (midazolam buccal, adrénaline auto-injectable) : rangés avec la fiche d'urgence individuelle ; pas d'auto-injecteur collectif (outil chariot DOTR).
- **Enfants** : doses par âge ou mg/kg, poids actualisé, matériel pédiatrique.
- **ESMS handicap** : liste de médicaments à risque réservés aux IDE (ARS IDF) ; à défaut de référentiel chariot, procédure ARS/OMéDIT IDF.
- Démonstration du chariot / sac à tous (formation gestes et soins d'urgence).

Sources : Outil chariot d'urgence DOTR (validé 26/09/2026) · OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap (01/2025)

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.